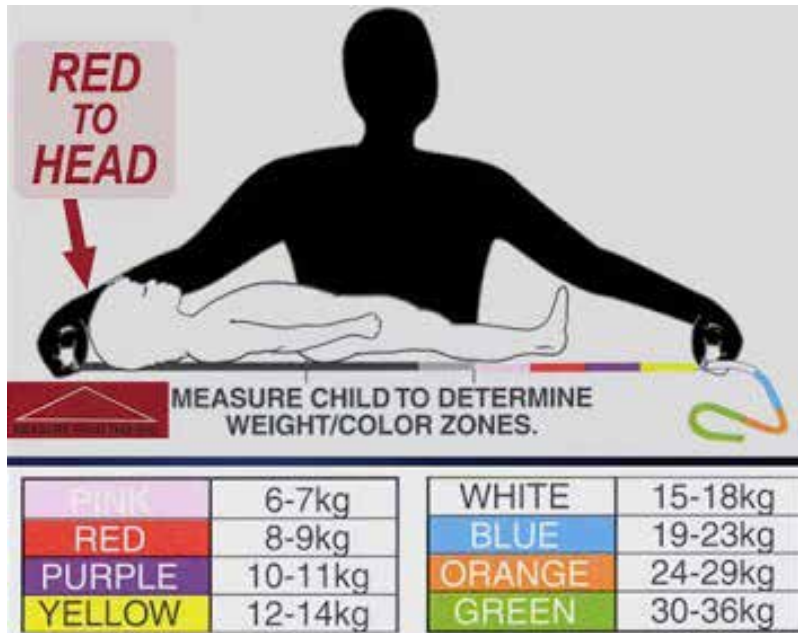


בטיחות ומיומנות

למרות החשיבות של מהירות ההגעה, אסור להזניח את הבטיחות. רצוי שהצוות המפנה יכלול מטפלים שמו-סמכים לבצע פרוצדורות מתקדמות בילדים, ושיכולים לזהות מקרי חירום האופייניים לילדים שעלולים להתפתח בזמן הנסיעה. יש לוודא שיש ברכב המפנה ציוד מתאים לטיפול בילדים. כמו כן, יש צורך בידיעת מינוני תרופות המתאימים למשקל הילד. אפשר ליצור טבלה נפרדת עם תרופות חירום הנפוצות יחד עם המינון המתאים לילד לפי משקלו. סרגל ברסלאו (Broselow tape) הוא שיטה מהירה לקביעת מינון תרופה בילדים (איור 21.15).



איור 21.15 סרגל ברסלאו (Broselow Tape)
סרגל המסייע לקבוע מינונים של תרופות בילדים.

התעללות בילדים

גורם טראומה נוסף בילדים הוא התעללות על ידי מבוגרים (איור 21.16). המבוגר המתעלל יכול להיות הורה, אחים ואחיות (גם לא מבוגרים), קרוב משפחה אחר, אפטרופוס, משגיח (כמו שמרטף) ואחרים. אפשר לזהות מקרים שבהם יש חשד להתעללות בעזרת סימנים שונים, ובמקרים שבהם עולה חשד להתעללות, יש חובת דיווח לגורם הרפואי הבא ולרשויות החוק.

בישראל במצבים מסוימים יש חובת דיווח על פי חוק חובת דיווח (חוק העונשין התשמ"ט-1989) לגורמים שונים כמו משטרה או פקידת סעד. בכל מקרה יש לזכור שמטרתם של צוותי הרפואה של מד"א היא הטיפול הרפואי בילד או בתינוק הנפגע ולא הטיפול בהתעללות עצמה - זאת משאירים לגורמים המתאימים.

סימנים המרמזים על התעללות אפשר למצוא לפי אופי הפגיעה ולפי גורמים נלווים (פירוט בהמשך). יש לשמור על רמה מסוימת של חשדנות במקרים המתאימים (ראו איור 21.16 ופירוט להלן).

סימנים מחשידים להתעללות

סיפור המקרה

סימנים שיכולים להחשיד שמדובר בהתעללות כוללים חורים בסיפור המקרה, למשל סיפור מקרה שאינו תואם את סוג הפגיעות ועוצמתן, חוסר עקביות בסיפור המקרה, סיפור מקרה שאינו תואם את השלב ההתפתחותי של הילד או פגיעות לא מוסברות.

התנהגות חשודה

אם עבר פרק זמן ארוך בין האירוע עד הקריאה לעזרה עולה חשד שיש ניסיון להסתיר. מבוגר שמאשים את הילד שניסה לפגוע בעצמו בכוונה, האשמת צד שלישי או מבוגר שמנסה להגן על מבוגר אחר יותר מאשר על הילד, גם אלה מעוררים חשד להתעללות.

כאשר נכנסים לזירת אירוע יש לבדוק את התנהגות הנוכחים. ילד בדרך כלל מעדיף את הסביבה המגוננת של ההורה. אם ילד מתרחק מההורה, כנראה ההורה אינו סביבה מגינה. ילדים במצב תת־תזונה קיצוני, לבושים בבגדים שאינם מתאימים למזג האוויר למשל, היעדר ניקיון, כל אלה מעוררים חשד להזנחה מצד המבוגר המטפל ואולי אף להתעללות. ייתכן שילד שמגיב בצורה יוצאת דופן – הוא שקט מדי, מופנם מדי – הוא ילד שפוחד לדבר ולבכות. התנהגות זו יכולה לרמוז על אלימות ברקע.

אופי הפגיעות

פגיעות מסוימות המרמזות על התעללות הן בעיקר פגיעות שאינן שכיחות בילדים, והצוות הרפואי נדרש לטפל בהן. פגיעות כאלה כוללות פגיעות יוצאות דופן (נשיכות, סימני חבל, כוויות מסיגריות), פגיעות במקומות לא רגילים בגוף או באזורים רבים בגוף; פגיעות רבות יותר ממה שרגיל למצוא בקבוצת גיל מסוימת ופגיעות שאינן שכיחות בילדים, כדוגמת פגיעות חזה ובטן או תסמונת התינוק המנוער. פגיעות חוזרות ונשנות, למשל פגיעות בשלבי החלמה שונים, אף הן מעוררות חשד להתעללות.

כוויות, חבורות ופצעים

חשוב לשים לב לפגיעות כמו זיהומים ישנים בעור, כוויות ופצעים בשלבי החלמה שונים. ממצא כזה עשוי להעיד שהמטופל הילד סובל מהתעללות בקביעות. אם כי יש לזכור שפציעות וכוויות, גם אם אינן מופיעות בתדירות – די בהן כדי לעורר חשד להתעללות.

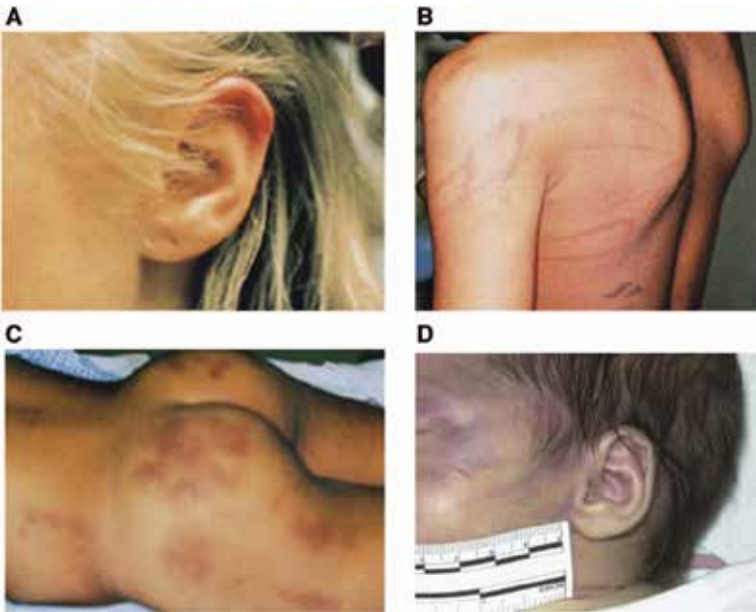
לפעמים סוג הפציעה או הכוויה מראה שהיא נעשתה בכוונה תחילה. דוגמה לכוויה כזו היא כוויה בקוטר המ־תאים לסיגרטה שאולי עוד יש בה סימני אפר. שכיח למצוא כוויות של סיגריות בכפות הידיים, הרגליים או בבטן. למעשה כל פצע או כוויה עם גבולות ברורים יחסית יעידו שכנראה הגורם הוא חפץ מסוים ששימש בהתעללות, ולא תאונה. כוויות היקפיות וכוויות בזוגות (בשתי כפות הידיים או בשתי כפות הרגליים) אופייניות להתעללות, והן נגרמות מהכנסת ידי הילד או רגליו לאמבט מים חמים מאוד וכדומה. נוסף על ידיים, המתעללים נוטים גם לגרום לכוויות באזור המפשעה.

עוד סימן הוא פצע היקפי בקצות הגפיים שהם פצעי לחץ עקב קשירה הדוקה של הידיים או הרגליים.

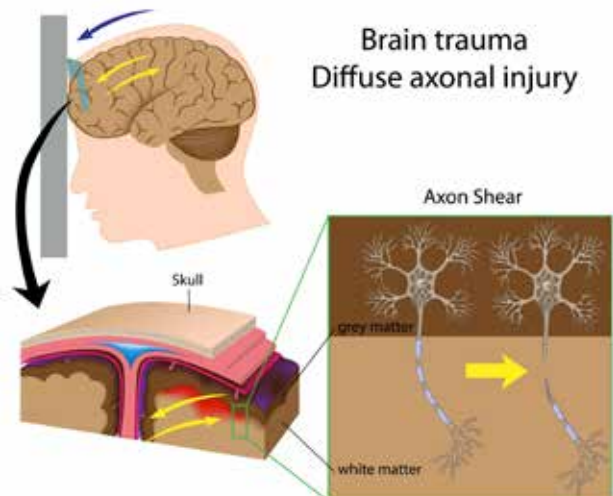
חבורות שונות יכולות לספר סיפור, אך לא כולן בהכרח מהתעללות. סימנים בגב תחתון ובישבן הם כנראה בשל הענשת הילד; חבורות באזור מפשעה וירכיים עקב תאונות בשירותים בגלל אסלה לא בגודל מתאים; סימני חבלה באוזניים ובפנים יכולים להיגרם מסטירות; פגיעה בשפה העליונה יכולה להיות תוצאה של האכלה בכוח.

או הכנסה בכוח של מוצץ; סימנים בצורת אצבעות או רק קצות האצבעות נגרמים מלפיתה חזקה (שבתינוקות יכולה לגרום לשבר).

חבורה בצורה של זוג חצאי עיגול עם סימני שיניים מעידה על נשיכה, שלפי הגודל אפשר לשער אם הנושך הוא ילד או מבוגר; סימנים ברוחב 2-5 ס"מ הם כנראה מחגורה, חבורה בצורה משונה יכולה להיות ממכה מחפץ כמו נעל, וסימנים בצוואר יספרו על חנק.



איור 21.16 סימני התעללות אופייניים



איור 21.17 התינוק המנוער

ניעור התינוק יכול לגרום לדימום סאבדורלי ואף למוות.

שברים

שברים הם פגיעה שאינה שכיחה בילדים, אך הם יכולים להתאים למאפיינים של התעללות. שברים אצל תינוקות יחשדו בהתעללות שכן אין זה סביר למצוא שברים אצל ילדים שאינם עוסקים עדיין במשחקי ספורט או מסוגלים לטפס על סולם. שברים בצלעות, בשכמות ובגפיים אף הם חשודים כנובעים מהתעללות. בילדים מתחת גיל שנתיים, עצם יכולה להישבר אף מסיבוב גפה בלבד. לפיתה חזקה וסיבוב ידו של התינוק יכולים לגרום לשבר באחת מהעצמות ביד.

מוות בגלל פגיעת ראש

גורם המוות הראשי בילדים בגלל התעללות הוא דימום סאבדורלי. יש לחשוד בכל מקרה של ילד במצב תרדמת או שמפרכס, במיוחד אם אין היסטוריה של פרכוסים. הדימום לתוך המוח יכול להיגרם ממכה חזקה מידו המוטחת של מבוגר או מהטחת הילד בקיר או בדלת.

נענוע חזק של הילד יגרום לקריעה של ורידים מוחיים, ואלה יגרמו לסימנים של תסמונת התינוק המנוער (איור 21.17). בעקבות ניעור וטלטול התינוק רואים סימנים אלו: דימומים ברשתית, חוסר שקט, רמת הכרה נמוכה, הקאות ומרפסים בולטים. מרפס בולט בתינוקות הוא סימן ל-ICP גבוה בתינוקות, וגם כאן יש לשקול שאולי מדובר בהתעללות.

פגיעות בטן

פגיעת בטן פנימית היא גורם שני במעלה למוות עקב התעללות, והוא יכול להיגרם ממכת אגרוף או חבטה בבטן. הקאות חוזרות, בטן קשה, אין קולות בהאזנה לבטן, רגישות מקומית (גם ללא סימן חבורה) - כל אלה יכולים להיות סימן לפגיעת בטן. כאשר יש רגישות בטנית מפתיעה בגלל חוסר התאמה לסיפור מקרה (למשל הכחשה של הורים לטראומה בטנית) יש לחשוד שמדובר בהתעללות.

התעללות מינית

התעללות נוספת שיש להביא בחשבון היא התעללות מינית. התעללות מינית נפוצה יותר כלפי בנות אבל קיימת גם כלפי בנים. חשד להתעללות כזו יעלה אם ניתקל בילדות צעירות בהיריון, נראה דימומים (או סימני דם בכלל) באזור המפשעה או כאבים בהפרשות. במצב כזה נדרשת עדינות, ורצוי טיפול על ידי איש מקצוע שהוא בן מינו של המטופל או המטופלת. פינוי למתקן מתאים והעברת המידע לצוות הרפואי הבא.

מידע שקרי

הבעיה הגדולה בהתעללות על ידי מבוגר היא שהוא האדם שעליו אנחנו צריכים לסמוך כגורם מספק מידע, ודווקא הוא עלול לספק מידע שקרי ולהעלים נתונים חשובים. כאשר יש חשד להתעללות יש להתייחס בספקנות לסיפור המקרה, לבצע בדיקה מלאה של הילד הנפגע ולצפות להפתעות. את החשד להתעללות יש להעביר לצוות הרפואי הבא בצורה שבה המבוגר לא יחשוד שהתעורר חשד כלפיו. בסופו של דבר על הצוות הרפואי להתמקד בטיפול הרפואי, בלי שהמבוגר יפריע בטיפול. את החשד יש להעביר לגורם המוסמך.

ההבדלים האנטומיים והפיזיולוגיים בין ילדים למבוגרים, לפי סכמת ABCDE

בטבלאות להלן מוצגים ההבדלים האנטומיים בין ילדים למבוגרים ומוסברת החשיבות הקלינית של כל אחד מהם. הטבלאות מוצגות לפי סכמת ABCDE

טבלה 21.2 הטיפול בדרכי האוויר אצל ילדים (Airway: A)

החשיבות הקלינית	הבדלים בדרכי האוויר בין ילדים למבוגרים
דרכי האוויר נחסמות בקלות, בצקת וריר מגדילים את ההתנגדות	דרכי אוויר קטנות יותר, קוטר הקנה בערך כקוטר הזרת
יש לדאוג שמעברי האוויר באף יהיו נקיים מהפרשות כדי להימנע ממצוקה נשימתית	תינוקות נושמים כמעט רק דרך האף בחודשי חייהם הראשונים
הלשון עלולה לחסום בקלות את דרכי האוויר	הלשון גדולה ביחס לפה
סיכון גדול יותר של חסימה בגלל בצקת או דימום	סחוס הלרינקס (larynx) רך יותר
כל היפראקסטנציה (מתיחת הראש אחורנית) או פלקסיה (כיפוף הצוואר קדימה ולמטה) יגרמו לסגירה של דרכי האוויר	בדרכי האוויר בעיקר רקמה רכה (סחוס)
סיכון גבוה של חסימה ושאיפת מזון; קושי באינטובציה	הלרינקס קדמי וגבוה יותר בילדים
אינטובציה ושמירה על מקום הטובוס קשה יותר; אינטובציה של הסימפון הימני שכיחה	האפיגלוטיס רך, הקנה קצר ויש יותר מלפורמציות (מומים, עיוותים) בדרכי האוויר
האטימה של הטובוס מספיקה; רצוי להשתמש בטובוס ללא בלון בשנה הראשונה לחיים	סחוס הקריקואיד הוא המקום הצר ביותר בלרינקס בניגוד למיתרי הקול במבוגר

טבלה 21.3 הטיפול בנשימה אצל ילדים (Breathing: B)

החשיבות הקלינית	הבדלים בנשימה בין ילדים למבוגרים
ככל שהילד צעיר יותר הוא חשוף למצוקה ואי־ספיקה נשימתית; מתעייף מהר	פחות מנגנוני פיצוי מאשר במבוגר בגלל הגודל של איברי מערכת הנשימה ואי־הבשלות שלהם
רתיעות (רטרקציות בין־צלעיות) שכיחות; רתיעות קשות מקטינות את היכולת ליצור נפח נשימה מספק	צלעות וסטרנום סחוסיים, קיר בית החזה רך יותר ובעל היענות גבוהה
התינוק נושם רק בעזרת הסרעפת, ולכן התינוק תלוי בסרעפת לנשימה; הצבת התינוק במאונך עוזרת לפ־עולת הסרעפת	שרירים בין־צלעיים לא מפותחים
כל לחץ על הסרעפת מלמעלה או מלמטה מפריע למאמץ הנשימתי	תינוקות נושמים בעיקר נשימת בטן
התפשטות בית החזה קטנה יותר	הצלעות אופקיות יותר
פחות שטח פנים לשחלוף גזים	נאדיות קטנות יותר ומספרן מועט
כל חסימה בדרכי האוויר משפיעה על חילוף הגזים בצורה חמורה יותר	מסלולים חלופיים של ונטילציה אינם מפותחים
סיכון מוגבר לדליפת אוויר סביב הטובוס ולבצקת	פחות רקמה אלסטית ורקמת קולגן בריאות
היפוקסיה מתרחשת מהר יותר במצוקה נשימתית	הקצב המטבולי בתינוקות גבוה יותר
קולות הנשימה נשמעים בבירור בבדיקה	קירות בית החזה דקים

(*) רתיעות, רטרקציות בין־צלעיות הן משיכת הצלעות פנימה בעת נשימה מאומצת

טבלה 21.4 טיפול במחזור הדם אצל ילדים (Circulation: C)

החשיבות הקלינית	הבדלים במחזור הדם בין ילדים למבוגרים
עלייה בקצב כפיצוי לתפוקת לב תפוקת הלב יורדת במהירות גדולה	היענות, קונטרקטיליות (יכולת התכווצות הלב) ונפח הפעימה קטנים מאשר אצל מבוגר
עתודות מעטות	תפוקת הלב בתינוקות גבוהה
איבוד דם מועט יכול להיות קריטי	נפח דם קטן
ירידה בלחץ דם מאוחרת ופתאומית (לאחר איבוד מעל 25% מנפח הדם)	בשל יכולת טובה לכווץ כלי דם ייתכן פיצוי לזמן ארוך, אך ההידרדרות מהירה מאוד אחר כך
סיכון גדול יותר להתייבשות	חלק גדול יותר ממשקל הילד הוא מים (50% בילד לעומת 25% במבוגר)
הכליות אינן יכולות להסתגל ביעילות לשינויים בנפח הנוזלים	יכולת ריכוז השתן; איכות השתן ירודה בתינוקות בחודשי החיים הראשונים
יילודים רגישים מאוד לגירויים פראסימפטטיים	ביילודים המערכת הסימפטטית אינה בשלה

טבלה 21.5 הטיפול בניורולוגיה אצל ילדים (Disability: D)

הבדלים בין ילדים למבוגרים	החשיבות הקלינית
כל חלקי המוח קיימים אך המוח ממשיך לגדול	אי אפשר לנבא שלמות ההחלמה בעקבות פגיעה עצבית
עצבים קרניאלים תקינים בלידה; החזרי יילוד והחזרים מגינים קיימים מהלידה	אפשר להעריך את המצב הניורולוגי לפי תקינות החזרים בהתאם לגיל
החזר בבינסקי* קיים עד תחילת ההליכה	אחרי גיל שנתיים החזר בבינסקי חיובי הוא פתולוגי
בתינוקות מערכת העצבים האוטונומית אינה מפותחת	היכולת לשמור על חום הגוף כתגובה לסביבה מוגבלת
תנוחות התינוק היא בעיקרה בפלקסיה (כיפוף)	זהו מדד חשוב למצב הניורולוגי של התינוק
תפרי הגולגולת אינם מתאחים עד גיל 16-18 חודשים	הראש יכול לגדול בתגובה לעלייה הדרגתית בלחץ התוך-גולגולתי

טבלה 21.6 החשיפה בטיפול בילדים (Exposure: E)

הבדלים בין ילדים למבוגרים	החשיבות הקלינית
שטח פני הגוף בתינוקות וילדים קטנים גדול ביחס למשקלם	נטייה להיפותרמיה בגלל איבוד חום לסביבה; איבוד נוזלים רב בגלל שטח פנים גדול
תינוקות צעירים משלושה חודשים אינם מסוגלים ליצור חום בצמרמורת ושורפים שומן לצורך כך	תהליך כזה מגביר את צריכת החמצן ותורם להיפוקסיה
מערכת החיסון ביילודים עד גיל חודש אינה מפותחת	שכיחות גבוהה של ספסיס; אי־אפשר להסתמן על התמונה הקלינית (הקליניקה)
שינויי משקל ניכרים קורים בינקות ובגיל הילדות	הערכת המשקל חשובה במצבים מסכני חיים
קצב המטבוליזם של תרופות בילדים שונה	מינוני תרופות לפי משקל הילד
לתינוקות וילדים קטנים מאגרי גליקוגן מוגבלים	נטייה להיפוגליקמיה בילדים חולים או פצועים
קצב מטבולי גבוה מהמבוגר	צריכת נוזלים בסיסית גבוהה מהמבוגרים
ראש גדול יחסית לממדי הגוף והוא הנקודה המובילה בטרומה; מרכז כובד גבוה	סיכון גבוה לחבלות ראש ולטביעה בגופי מים קטנים (דלי, גיגית); חוסר יציבות של הילד
הסתיידות עצם לא מושלמת, עצמות גמישות	היעדר שבר אינו שולל פגיעה באיברים פנימיים
עצמות הילדים בתהליך גדילה	שברים מחלימים מהר יותר, אך פגיעה בלוחית הגדילה עלולה לעצור את התארכות העצם

* החזר בבינסקי (Babinski), סימן בבינסקי - הוא תופעה ניורולוגית המופיעה בתינוקות עד גיל שנה-שנתיים: גירוי כף הרגל, ואפילו ליטוף, גורם לפריסת האצבעות ולבוהן להימתח כלפי מעלה (לעומת מבוגרים שבהם הגירוי יגרום לכיפוף כף הרגל). זוהי תופעה תקינה עד גיל שנה-שנתיים. לאחר גיל שנתיים הפקת החזר מעידה על פגיעה ניורולוגית.

סיכום עקרונות הטיפול בילדים

בכל טיפול בילד יש לזכור שהצוות מטפל בנפגע שזקוק להגנתו ולתמיכתו. אם הטיפול יינתן כראוי, בחיוך ובאמפתיה עולים לא רק סיכויי ההחלמה של הילד הנפגע אלא גם תחושת הביטחון שלו כלפי "האנשים הזרים עם המחסים". ונוסף על כך עולה תחושת הרווחה של הילד ומשפחתו.

עקרונות הטיפול מתייחסים לשני היבטים: טיפולי פיזי וטיפול רגשי.

הטיפול הפיזי בילדים

ילדים ותינוקות עדינים יותר ממבוגרים, הם בתהליכי גדילה והתפתחות ולומדים בכל יום דבר־מה חדש. המערכות הפיזיולוגיות בגופם נמצאת בהתפתחות מתמדת, ולכן דורשת פיצוי מתמיד. יש להתייחס אל הילד בעדינות הנדרשת, בכובד הראש הראוי ובשילוב המחשבה הקלינית המתאימה, מכיוון שהידרדרות של ילד או תינוק תקרה בדרך כלל בפתאומיות ובמהירות. בל נשכח שכל טיפול פולשני כמו עירוי וטובוס יכולים להשאיר אצל הילד חותם לכל החיים, למשל נזק במיתרי הקול.

הטיפול הרגשי בילדים

ילד (ותינוק) קשור מאוד להוריו, הוא מפחד שזנחו אותו ומפחד מהלא נודע. לכן חשוב שהמטפלים ישרו אווירה נינוחה בטיפול, כאילו הטיפול הוא מעין משחק איתו. כאשר החזות של המטפל רגועה ומחויכת גם ההורים נרגעים. ההורים הם חלק חשוב בטיפול, ולעולם אין להפריד אותם מהילד אם אין בכך צורך. יש לדאוג שגם הם יקרינו לילד נינוחות ורוגע, עד כמה שאפשר. במקרים רבים הילד לחוץ יותר בגלל הוריו הנרגשים והבוכים מאשר בגלל החתך המדמם בראשו. לכן הרגעת ההורים היא חלק אינטגרלי מהטיפול בילד.

הורה רגוע = ילד רגוע = טיפול רגוע וממצאים מדויקים יותר.

המטפל מגיע במצבי חירום לסיטואציה קשה עבור ההורים. לכן על המטפל להיות מקצוען ככל האפשר - רגוע, מחייך בנעימות, מדבר לילד כשווה אל שווה, מדבר בשפה המובנת לו, אינו משקר לילד, הוא עדין וסבלני ומאפשר לו להחזיק צעצוע אהוב; מטפל מקצועי לא מפריד בין הילד להוריו ומסביר כל פעולה לפני ביצועה - גם לילד וגם להורים.

דגשים חשובים בטיפול בילדים

- (1) להישאר רגועים
- (2) לחייך בנעימות
- (3) לדבר עם הילד כשווה אל שווה
- (4) להיות סבלניים ועדינים
- (5) לא להפריד בין ילד להוריו
- (6) לדבר עם ילד בשפה שיבין
- (7) לעולם לא לשקר לילד
- (8) לאפשר לילד להחזיק צעצוע
- (9) להסביר כל פעולה לפני ביצועה
- (10) לא לשכוח להסביר להורים את הפעולות

טבלה 21.7 הדירוג בסולם גלזגו (Glasgow Coma Scale: GCS)

ניקוד	פעולה		
4	עצמונית	פקיחת עיניים	E
3	בתגובה לדיבור		
2	בתגובה לכאב		
1	אין		
5	תקין; מתמצא	דיבור	V
4	מבולבל		
3	מילים לא ברורות		
2	הברות		
1	אין		
6	מבצע פקודות	תנועה	M
5	ממקם כאב		
4	נסוג מכאב		
3	כיפוף לא תקין (דקורטיקציה)		
2	יישור לא תקין (דצרבציה)		
1	אין		

טבלה 21.8 התאמת מרכיבי הדיבור בדירוג סולם גלזגו לילדים

ניקוד	פעולה		
5	מילים נכונות או חיך חברתי, מקבע מבט ועוקב	דיבור	V
4	בוכה, אבל ניתן להרגעה		
3	בוכה בתגובה לכאב		
2	קולות לא ברורים בתגובה לכאב		
1	אין תגובה		

טבלה 21.9 ערכי לחץ דם תקינים בילדים על פי גיל

גיל	לחץ דם סיסטולי (ממ"כ)	לחץ דם דיאסטולי (ממ"כ)
12 שעות (> 1000 ג')	59-39	36-16
12 שעות (3 ק"ג)	70-50	45-25
יילוד (96 שעות)	'90-60	60-20
תינוק (6 חודשים)	105-87	66-53
ילד קטן (שנתיים)	105-95	66-53
ילד בגיל בית ספר (בן שבע)	112-97	71-57
נער (בן 15)	128-112	80-66

טבלה 21.10 קצב הלב בילדים בריאים

גיל	בעירנות	ממוצע	בזמן שינה
יילוד - 3 חודשים	205-85	140	160-80
3 חודשים שנתיים	190-100	130	160-75
שנתיים - 10	140-60	80	90-60
< 10 שנים	100-60	75	90-50

מצבי חירום נשימתיים בילדים

מצוקה נשימתית - היא השקעת מאמץ בפעולת הנשימה. חשוב לאבחן מצוקה נשימתית כי היא הגורם השכיח ביותר למצבי חירום בתינוקות. אפשר למנוע מקרי מוות רבים בתינוקות אם מאבחנים בזמן ומטפלים בכשל הנשימתי.

כשל נשימתי - הוא חמצון או אוורור לקוי; בין אם יש מצוקה נשימתית או אין.